

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA

NS 22232882342 | 495

MARCOS ANTONIO RUGGIERI FRANCO

IDADE: 62 | PESO: 85 | ALTURA: 1,72 | PROFISSÃO: Físico (Aposentado)

SINTOMAS: Dorco, cansaço

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Atorvastatina (colist) | Levotiroxida

MÉDICO: Dr. Flávio Augusto

MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S (X) N

EXERCÍCIO FÍSICO: 2x academia (personal)

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ: S ALMOÇO: S LANCHE: N JANTAR: 19:30

HORA QUE DORME: 0h

HORA QUE ACORDA: 9h - 9:30h

COCHILHO () S (X) N

DORME ACOMPANHADO: (X) S () N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: (X) S () N / DORMEM NO QUARTO: () S (X) N

PET NO QUARTO: () S (X) N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA (X) N

FUMO: () S () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: 1-2x

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI:

IAH: 25,2cm | SPO2: 77%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: colúmbia | tireoide

CIRURGIAS: (S) NASAL (S) AMIGDALECTOMIA

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (S) ENDOCRINA () CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA

(N) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAMA COM CPAP: (X) S () N

SPO2 C/ CPAP: 89%

PRESSÃO NO EXAME: 8cmH2O

05/11/24 Amelição

Comprim. Bismar Auto
max. N30 (S)

08/11/24 P=8cmH2O

IAH=6,2cmH2O

↑ P=8,2cmH2O

mao: 6h27'

fuga: 8,4l/min

Natasha

04/12/24 P=8,2cmH2O

IAH=2,7cmH2O

sem adaptado.

mao= 6h20 min.

fuga= 5l/min.

Silvia

14/02/25 P=8,2 cmH₂O

IAH= 1,7 e/h

m de uso: 6h32'

fuga: 2,2 l/m

Bem adaptado

3/ queixas

Natasha

AirMini

P=8,2 cmH₂O

IAH= 2,5 e/h

fuga= 1,5 l/min

m uso: 6h18

02/04 a 16/04

16/05/2025 = P: 8,2 cmH₂O

IAH: 1,7 e/h

m uso: 7h00min

fuga= 18 l/min

Silvia

Nome: MARCOS ANTONIO RUGGIERI FRANCO Peso: 85 kg
Data de Nascimento: 12-6-1962 Altura: 1,72 m
IMC: 28,73 Médico: DR. FLAVIO AUGUSTO
Sexo: Masculino PASSARELLI PRADO
Data do exame: 10-10-2024 Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 10-10-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 406,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 4,5 e 159,0 minutos. O tempo total de sono foi de 346,0 min, eficiência de 85,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,7%; estágio N2: 54,0%; estágio N3: 21,0%; sono REM: 23,3%. O índice de despertares foi de 1,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 0,0/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 0 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 89%, permanecendo 0,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 91 bpm e NREM de 56 - 104 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco durante o sono.

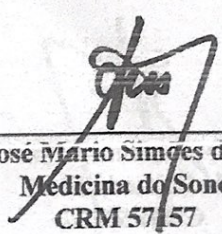
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157

Nome: MARCOS ANTONIO RUGGIERI FRANCO

Data de Nascimento: 12-6-1962

IMC: 28,73

Sexo: Masculino

Data do exame: 10-10-2024

Peso: 85 kg

Altura: 1,72 m

Médico: DR. FLAVIO AUGUSTO

PASSARELLI PRADO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 10-10-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 406,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 4,5 e 159,0 minutos. O tempo total de sono foi de 346,0 min, eficiência de 85,2% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,7%; estágio N2: 54,0%; estágio N3: 21,0%; sono REM: 23,3%. O índice de despertares foi de 1,3/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 0,0/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 0 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e a mínima de 89%, permanecendo 0,2% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 59 - 91 bpm e NREM de 56 - 104 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e porcentagem dos estágios do sono NREM dentro da normalidade;
3. latência para o sono REM aumentada;
4. número de despertares breves normal;
5. registro de ronco durante o sono.

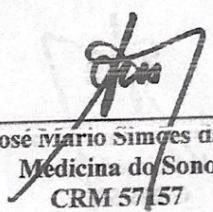
Exame polissonográfico para titulação de CPAP com melhor pressão terapêutica de 8 cmH2O.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157